

Czym jest *AvPD*

AvPD to nie nieśmiałość — to wzorec wycofania + poczucia nieadekwatności + nadwrażliwości na krytykę. Rozpowszechnienie: 1,5–2,5% populacji (Grant 2004). Zaburzenie tożsamości, nie cecha.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna

ŹRÓDŁO: DSM-5; Grant (2004); Lampe & Malhi (2018); Bamelis i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz 7 kryteriów DSM-5 dla AvPD (sekcja 01). **2** · Zrozumiesz **kluczową różnicę** między AvPD a osobowością schizoidalną (sekcja 02): „chcę vs nie chcę bliskości”. **3** · Sprawdzisz *u siebie*, ile kryteriów spełniasz (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, dlaczego krótka CBT na SAD *nie wystarcza* — potrzebny dłuższy protokół (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

AvPD (osobowość unikająca, ang. *Avoidant Personality Disorder*) wg DSM-5: **przenikający wzorec społecznego zahamowania**, poczucia *nieadekwatności* i nadwrażliwości na ocenę. Rozpowszechnienie 1,5–2,5% (Grant 2004). To *nie* nieśmiałość — to zaburzenie tożsamości: „jestem fundamentalnie wadliwy/-a”. Kluczowe od osobowości schizoidalnej: pacjent z AvPD **chce** bliskości, ale się jej boi. Bamelis 2014 (RCT): terapia schematów **74% wyzdrowienia** vs CBT 32% — wymaga 1–3 lat głębszej pracy.

01 7 kryteriów DSM-5 — diagnoza wymaga ≥4

1 · UNIKANIE AKTYWNOŚCI

Unika pracy wymagającej *kontaktu* z ludźmi — z lęku przed krytyką lub odrzuceniem. Wybiera role w tle (administracja, IT, analityka) zamiast bezpośrednich. Odrzuca awanse wymagające zarządzania innymi.

2 · NIECHĘĆ DO ANGAŻOWANIA

Niechęć do relacji *bez* pewności, że będzie lubiany/-a. „Nie zacznę, póki nie wiem”. Wymaga dowodów akceptacji *zanim* podejmie ryzyko — paradoks, bo dowody zwykle przychodzą *po*. Wieloletnia samotność.

3 · POWŚCIGAŁLIWOŚĆ W INTYMNOŚCI

Powściągliwość w bliskich relacjach — z lęku przed *upokorzeniem* nawet w bezpiecznym otoczeniu. Trudność z ujawnianiem słabości, marzeń, lęków — nawet wobec partnera od lat. „Maska” zostaje także w domu.

4 · SKUPIENIE NA OCENIE

Zaabsorbowanie krytyką/odrzuceniem. „Co o mnie pomyśleli?” trwa godzinami. Ruminacje pochłaniają wieczory; każda neutralna sytuacja interpretowana jako potencjalna krytyka.

5 · ZAHAMOWANIE W NOWYCH SYTUACJACH

Z poczucia nieadekwatności — w nowych sytuacjach *zamiera*, nie umie się zaangażować. Pustka w głowie, „nie mam co powiedzieć”, milczenie odbierane jako „nudny/-a” — co potwierdza schemat.

6 · POSTRZEGANIE SIEBIE

Postrzega siebie jako **nieudolnego/-ą społecznie**, gorszego/-ej. Bazowo, nie sytuacyjnie. Przekonanie *chroniczne*, niezmiennie nawet wobec dowodów przeciwnych (sukcesy są „dzięki szczęściu”).

7 · NIECHĘĆ DO RYZYKA

Niechęć do ryzyka i nowych aktywności — z lęku, że ujawnią *nieudolność*. Unikanie awansu, zmiany pracy, nowego hobby — życie zawężone do bezpiecznych, sprawdzonych obszarów.

02 ☉ AvPD vs osobowość schizoidalna — kluczowa różnica

AVPD

Chcę bliskości — boję się jej. Pragnienie kontaktu jest *silne*, ale lęk przed odrzuceniem silniejszy. Izolacja *mimo* tęsknoty. Cierpienie z powodu samotności. Cel terapii: **możliwe**.

OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA

Nie chcę bliskości. Brak pragnienia kontaktu. Komfort w samotności. Cierpienie zwykle *nie* z izolacji. Inny protokół — i inna ramówka cierpienia. Często *nie* zgłasza się sama.

Millon (1981) jako pierwszy oddzielił te dwa wzorce: AvPD to *aktywne unikanie* z pragnieniem bliskości; schizoid to *brak pragnienia*. Test różnicujący: „*gdybyś wiedział/-a, że nie zostaniesz odrzucony/-a — czy chciałbyś/-abyś być blisko ludzi?*” AvPD: **tak**. Schizoid: *nie*.

03 ✎ Sprawdź u siebie — ile kryteriów spełniasz

- ☐ 1. Unikam aktywności wymagających kontaktu z ludźmi — z lęku przed krytyką
- ☐ 2. Nie zacznę bliskiej relacji, póki nie wiem, że na pewno mnie chcą
- ☐ 3. W bliskich relacjach jestem powściągliwy/-a — boję się wyśmiania
- ☐ 4. Po sytuacjach społecznych godzinami analizuję, co o mnie pomyśleli
- ☐ 5. W nowych sytuacjach interpersonalnych zamieram, ucieczka, brak słów
- ☐ 6. Widzę siebie jako gorszego/-ą, mniej atrakcyjnego/-ą, nieudolnego/-ą społecznie
- ☐ 7. Unikam nowych aktywności z lęku, że pokażę moją nieudolność

4 lub więcej zaznaczeń + długotrwały, przenikający charakter = wskazana konsultacja diagnostyczna. *Sam wynik nie jest diagnozą* — diagnozę stawia specjalista po wywiadzie klinicznym.

04 💡 Dlaczego krótka CBT na SAD nie wystarcza

KRÓTKA CBT (16 SESJI)

Ekspozycja na sytuacje społeczne. Restrukturyzacja myśli automatycznych. Trening umiejętności. Działa na *objawy lęku*, ale schemat „jestem wadliwy/-a” **pozostaje nietknięty**.

TERAPIA SCHEMATÓW (1–3 LAT)

Bamelis 2014: 74% wyzdrowienia (vs CBT 32%). Praca z trybami: *Detached Protector*, *Lonely Child*, *Punitive Parent*. Ekspozycja + tożsamość + wstyd + relacja terapeutyczna jako bezpieczna baza.

Klucz: AvPD to *nie* nieśmiałość ani cecha charakteru — to **upośledzające zaburzenie tożsamości**: „jestem fundamentalnie wadliwy/-a”. Niedodiagnozowane (Lampe & Malhi 2018), bo mylone z lękiem społecznym (SAD), depresją, „introwersją”. Kluczowa różnica od schizoida: **chcę** bliskości, ale się jej boję. Stąd cierpienie samotności *mimo* tęsknoty. Skuteczne podejście: terapia schematów (Bamelis 2014: 74% wyzdrowienia w randomizowanym badaniu kontrolowanym vs 32% standardowej CBT). Ramy czasowe: 1–3 lata. **Diagnoza otwiera drogę** — bez niej pacjent uznaje, że „taki się urodziłem/-am” i rezygnuje.